REVISE PARA PROVA · SEU RESUMO EM UMA ÚNICA FOLHA

Leucemias e Linfomas

Leucemias agudas, emergências onco-hematológicas e linfomas em uma página

MAIS COBRADO · **1º LPA**: CIVD → ATRA na suspeita · **2º Neutropenia febril**: antibiótico na 1ª hora · **3º Linfonodo suspeito** → biópsia excisional · **4º Hodgkin × não Hodgkin**

1 Leucemia aguda: diagnosticar

≥ 20% de blastos na medula

Falência medular: anemia, **plaquetopenia** (petéquias), neutropenia (febre). **Infiltração:** dor óssea, hepatoesplenomegalia, linfonodos, hipertrofia gengival (monocítica), massa mediastinal (LLA-T).

Caminho: hemograma + esfregaço → emergências (coagulograma, lise, leucometria, febre) → **mielograma** + **imunofenotipagem** (separa LMA × LLA) + citogenética/molecular (risco).

	LLA	LMA
Quem	**Criança, pico 2–5 anos** (câncer infantil mais comum)	**Adulto**, mediana ~70 anos
Marcadores	TdT+; B: CD19, CD10, CD22 · T: CD3, CD7	MPO+, CD13, CD33, CD117 · **bastonetes de Auer**
Genética	Hiperdiploidia e ETV6::RUNX1 = bom · **BCR::ABL1 (Ph+)** → inibidor de tirosina-quinase · KMT2A no lactente = ruim	ELN 2022: favorável t(8;21), inv(16), NPM1 · adverso **TP53**, cariótipo complexo
Tratamento	Indução → consolidação → **profilaxia do SNC** (intratecal) → manutenção **6-MP + metotrexato** (2–3 anos). Cura 85–90%	**"7 + 3"** (citarabina + antraciclina) → altas doses ou TCTH alogênico · idoso: **azacitidina + venetoclax**

Bom prognóstico na LLA: 1–9 anos, leucócitos < 50.000, LLA-B, **doença residual mínima negativa** no fim da indução (o fator mais forte).

2 Leucemia promielocítica (LPA)

t(15;17) PML::RARA

Chega com **CIVD + hiperfibrinólise** (sangramento é a principal causa de morte precoce). **Iniciar ATRA já na suspeita**. Repor plaquetas > 30–50 mil e fibrinogênio > 100–150. Baixo/intermediário risco: **ATRA + trióxido de arsênio**. **Síndrome de diferenciação** (febre, dispneia, infiltrado, derrame, ganho de peso) → **dexametasona 10 mg 12/12 h**. Cura > 90%.

3 Emergências

LISE TUMORAL
↑ ácido úrico, K, P · ↓ Ca (Cairo-Bishop) · Burkitt, LLA · **hidratação** + alopurinol ou **rasburicase** (não na G6PD).

LEUCOSTASE
Blastos > 100.000 + sintomas pulmonares/neurológicos · quimioterapia, hidroxiureia, leucaférese · **evite transfundir hemácias**.

NEUTROPENIA FEBRIL
≥ 38,3 °C ou ≥ 38 °C por 1 h + neutrófilos **< 500** → culturas + **cefepima/pip-tazo** na 1ª hora · MASCC ≥ 21 = baixo risco.

4 Linfomas

biópsia excisional · estadiamento de Lugano

Linfonodo suspeito: > 2 cm, endurecido, aderido, indolor, **supraclavicular**, > 4–6 semanas, sintomas B, > 40 anos → **biópsia excisional** (PAAF não classifica). Evite corticoide antes.

	Hodgkin	Não Hodgkin
Célula	**Reed-Sternberg CD15+ CD30+**	B na maioria (85–90%)
Quem	Bimodal: 15–35 e > 55 anos · EBV	Aumenta com a idade · HIV, EBV, HTLV-1, H. pylori
Disseminação	**Contígua**, mediastino (esclerose nodular)	**Não contígua**, extranodal frequente
Tratamento	**ABVD** ± RT · cura 80–90%	LDGCB: **R-CHOP** · folicular: observar se pouca doença

LNH: LDGCB (mais comum) · folicular **t(14;18) BCL2** · Burkitt **t(8;14) MYC**, "céu estrelado", lise espontânea · manto **t(11;14) ciclina D1** · MALT gástrico → **erradicar H. pylori**.

Lugano: I uma região · II ≥ 2 do mesmo lado do diafragma · III dos dois lados · IV extranodal disseminado. **Sintomas B:** febre > 38 °C, sudorese noturna, perda > 10% do peso em 6 meses.

Não confunda na prova

Os distratores que mais derrubam

1. **Leucemia aguda × crônica:** aguda é bloqueio da maturação (blastos); crônica acumula células maduras.
2. **Leucemia × linfoma:** leucemia começa na medula; linfoma no tecido linfoide.
3. **Imunofenotipagem** é o exame que separa LMA de LLA.
4. **Bastonete de Auer** = linhagem mieloide.
5. **LPA:** não espere o PML::RARA para começar o ATRA.
6. **Corticoide antes do mielograma** mascara a LLA.
7. **Dor óssea que acorda a criança** + citopenias: pense em LLA, não em artrite.
8. **Rasburicase** é proibida na deficiência de G6PD.
9. **Leucostase:** gasometria pode mostrar pseudo-hipoxemia; potássio pode vir falsamente alto.
10. **Neutropenia febril:** sem neutrófilo não há pus; a febre pode ser o único sinal.
11. **PAAF não basta** para linfoma: biópsia excisional.
12. **Supraclavicular esquerdo** (Virchow) = abdome; direito = tórax.
13. **Rituximabe reativa hepatite B:** rastrear antes.
14. **Hodgkin efeitos tardios:** bleomicina (pulmão), antraciclina (coração), RT (mama, tireoide).

Escores

IPI (LDGCB, 1 ponto cada): idade > 60 · **LDH ↑** · ECOG ≥ 2 · estádio III–IV · > 1 sítio extranodal. 0–1 baixo · 2 intermediário-baixo · 3 intermediário-alto · 4–5 alto.
Cairo-Bishop: ác. úrico ≥ 8 · K ≥ 6 · P ≥ 4,5 · Ca ≤ 7 (≥ 2 = laboratorial; + creatinina, arritmia ou convulsão = clínica).